

Câncer de mama · rastreio e biópsia

Nódulo suspeito ou mamografia alterada exige diagnóstico histológico por core biopsy. Receptores (RE/RP/HER2) e estágio guiam cirurgia, sistêmico e radioterapia.

Rastreio

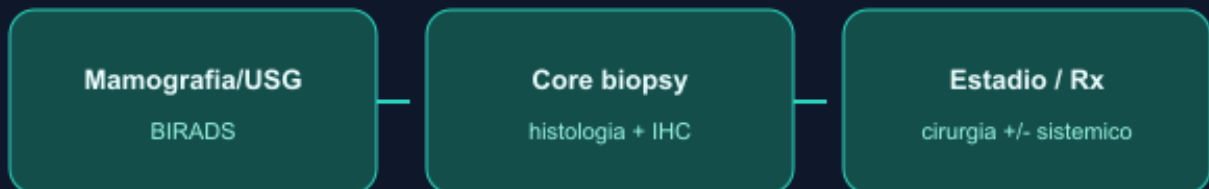
Lembre - Rastreio

Mamografia bienal tipicamente 50–69 anos no SUS (MS); sociedades podem sugerir início aos 40–45. Alto risco (BRCA/familiar): protocolo específico + RNM.

Não opere no escuro: histologia antes da conduta definitiva sempre que possível.

Nódulo / mamografia

Imagem -> biópsia -> estadiar



Conduta

- BIRADS 4–5: biópsia; 3: controle; 0: imagem adicional
- Cirurgia conservadora + RT se elegível; mastectomia conforme extensão/desejo
- Axila: biópsia de sentinela se clinicamente negativa
- Adjuvância: hormônio se RE+; anti-HER2 se HER2+; QT conforme risco

Sinais de alarme clínicos

Achado | Conduta

Nódulo duro fixo | Imagem + biópsia

Retração/pele em casca de laranja | Urgente mastologia

Secreção sanguinolenta unilateral | Investigar ducto/papiloma/Ca

Linfonodo axilar | Estadiar; biópsia

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

PAAF negativa não exclui câncer — prefira core. Gestação: massa suspeita também se biópsia; não atrase por 'esperar o parto' sem avaliação.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Mama: BI-RADS estratifica imagem; rastreamento com mamografia por faixa etária é clássico de preventiva/GO.

BI-RADS (ideia)

0 a 6 - conduta mental

0 - incompleto

mais imgs

1 - negativo

rotina

2 - benigno

rotina

3 - provavelmente benigno

6 meses

4 - suspeito

biopsia

5 - altamente sugestivo

biopsia

6 - ca conhecido

tratar

4-5 = biopsia | 3 = controle curto | 1-2 = rotina

Rastreamento mamário (ideia MS/INCA)

Público | Conduta clássica de prova

50–69 anos, risco habitual | Mamografia a cada 2 anos

40–49 anos | Não é rastreamento populacional universal no MS; individualizar

Alto risco (ex.: mutação, irradiação) | Início mais cedo ± RM — protocolo especializado

Achado palpável | Não 'esperar mamografia de rotina' — investigar

BI-RADS na prova

Lembre - BI-RADS na prova

BI-RADS 3 = seguimento curto. 4 e 5 = biópsia. 0 = exame incompleto — completar imagem antes de categorizar definitivo.

Clínica suspeita

- Nódulo duro, irregular, fixo; retração cutânea/mamilo
- Secreção sanguinolenta unilateral por único ducto
- Linfonodo axilar suspeito

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1